

هذا إجراء لإصلاح ندبة ضيقة عند عنق المثانة، أو عند موضع إعادة وصل المثانة بعد جراحة البروستاتا، ويُجرى بالكامل عبر منظار دون أي شق خارجي. يفتح الجراح الندبة ثم يخطط بطانة المثانة السليمة فوقها، فيلتئم الموضع مفتوحاً بدلاً من أن يعود إلى الانغلاق.

عن هذا الإجراء

بعد جراحة البروستاتا أو العلاج الإشعاعي، قد تتكوّن ندبة ضيقة عند عنق المثانة أو عند التقاء المثانة بالإحليل (مجرى البول) فتعيق تدفق البول. مجرد قطع الندبة كثيراً ما يُعيد انغلاقها لأنها تلتئم فوق نسيج ندبي.

تحلّ هذه التقنية — TUITMR (الشق عبر الإحليل مع إعادة توجيه الغشاء المخاطي بالتخييط) — هذه المشكلة:

- يقطع الجراح الندبة عبر المنظار لفتح القناة.
- ثم يستخدم أداة تخييط خاصة لجلب بطانة المثانة السليمة وخطاطتها فوق القطع — كرفرفة إصلاحية لكن عبر الإحليل.

النتائج الأولية مشجعة: نحو 9 من كل 10 حالات يظل المجرى مفتوحاً بعد إجراء واحد، وتقريباً جميعها بعد إجراء ثانٍ — مع خطر منخفض جداً لتسرّب البول في المجموعة الأولى المُبلّغ عنها.

هل هو آمن؟

يُجرى بالكامل عبر الإحليل بعيداً عن العمليات الروبوتية أو المفتوحة الأكبر المستخدمة لهذه الحالة. الأدلة الأولية واعدة، وتشمل انخفاض خطر تسرّب البول الذي قد يُعقّد تدخّلات أخرى. تشمل المخاطر النزيف وعدوى المسالك البولية وعودة الضيق. هذه تقنية متخصصة حديثة.

تعلم المصطلحات

عنق المثانة

فوهة المثانة حيث تضيق وتتصل بالإحليل.

تضييق عنق المثانة

ندبة ضيقة عند عنق المثانة تعيق تدفق البول.

تضييق موضع المغاغة

ندبة تضيق موضع إعادة وصل المثانة بعد جراحة البروستاتا.

الإحليل (مجرى البول)

الأنبوب الذي يحمل البول إلى خارج الجسم.

الغشاء المخاطي (البطانة)

البطانة الداخلية السليمة التي تُمدّ فوق الندبة لتُنبّيها مفتوحة.

المنظار البولي (Cystoscope)

الكاميرا الرفيعة التي يعمل الجراح عبرها.

سلس البول (Incontinence)

تسرّب البول — خطر تسعى هذه التقنية إلى إبقائه منخفضاً.

القسطرة (Catheter)

أنبوب رفيع يُترك في الإحليل لفترة قصيرة أثناء الالتئام.

هل سيولم؟ يُجرى الإجراء تحت التخدير فلا تشعر بشيء أثناءه. بعده، تَوقَّع حرقاناً خفيفاً وبولاً مصحوباً بقليل من الدم لأيام قليلة. تُترك قسطرة لفترة قصيرة. معظم المرضى يعودون إلى المنزل في اليوم ذاته أو بعد إقامة قصيرة.

كيف تستعدّ (قبل الإجراء)

- يُجرى تحت التخدير العام — اتّبع جميع تعليمات الجراحة (الصيام وإيقاف الأدوية، بما فيها مخفّفات الدم).
- تحليل البول للتحقق من غياب العدوى — يجب علاج أي عدوى أولاً.
- خطّط لوجود قسطرة لفترة قصيرة ورتّب لمن يوصلك إلى المنزل.

أخبر فريقك الطبي مسبقاً إذا كنت:

- تتناول مخفّف دم، أو لديك عدوى في البول حالياً
- أجريت جراحة بروتاتنا أو علاجاً إشعاعياً أو تدخّلات سابقة في هذه المنطقة

ما الذي يحدث أثناء الإجراء

- 1 تكون نائماً تحت التخدير وتُعطى المضادات الحيوية.
- 2 يُمرّر المنظار حتى موضع الندبة ويُوضع سلك توجيه للسلامة.
- 3 تُوسّع الندبة وتُقطع لفتح القناة.
- 4 بأداة تخييط تُمرّر عبر الإحليل، تُجلب بطانة المثانة السليمة وتُخاط فوق القطع، ثم تُترك قسطرة في مكانها.

بعد الإجراء

- تعود إلى المنزل في اليوم ذاته أو بعد إقامة قصيرة مع قسطرة لفترة وجيزة.
- تَوقَّع حرقاناً خفيفاً وبولاً وريدياً لأيام قليلة. الإكثار من شرب الماء يُساعد.
- تجنّب الرفع الثقيل والإجهاد لبضعة أسابيع.
- متابعة بمنظار (نحو 4 أشهر) للتأكد من بقاء المجرى مفتوحاً.

اتصل بفريقك الطبي إذا كان لديك:

- حمّى أو قشعريرة
- عجز عن التبوّل، خاصةً بعد إزالة القسطرة
- تسرّب بول غزير جديد
- نزيف غزير، أو جلطات دموية، أو ألم متصاعد

ثلاثة أمور تذكّرها

1. هذا إصلاح بلا شقّ لندبة عنق المثانة — تُفتح الندبة وتُغطّى ببطانة سليمة فتلتئم مفتوحة مع خطر منخفض لتسرّب البول.
2. للاستعداد: اتّبع تعليمات الصيام والأدوية، وعالج أي عدوى أولاً، وخطّط للقسطرة وللمن يرافقك.
3. الحرقان الخفيف والبول الوردي لأيام قليلة طبيعي، والمتابعة بمنظار تؤكد النجاح. اتصل فوراً عند الحمّى أو العجز عن التبوّل أو التسرّب الغزير أو النزيف الشديد.